

2025 年 03 月 09 日

痛风领域有望迎重磅新药，建议重点关注一品红

——医药行业周报（25/3/3-25/3/7）

投资评级：看好（维持）

证券分析师

刘闯

SAC: S1350524030002

liuchuang@huayuanstock.com

联系人

板块表现：



➤ **本周医药市场表现分析：**3月3日至3月7日，医药指数上涨1.06%，相对沪深300指数超额收益为-0.32%。本周创新药相关中小市值标的表现强劲，相关个股如热景生物、艾迪药业、海创药业、一品红等涨幅居前，创新药和AI医疗作为医药板块的“科技股”近期表现持续活跃。随着业绩密集披露期的到来，建议关注：1）年报和一季报业绩，如出口链、中药、医疗设备、医疗服务等领域的个股；2）医药最为明确的方向创新药，继续关注热景生物、一品红、科伦药业、信立泰、恒瑞医药、迪哲医药、泽璟制药、三生制药、科伦博泰、康方生物、中国生物制药、百济神州等；3）精选有基本面支撑的AI医疗公司。

➤ **医药指数和各细分领域表现、涨跌幅：**本周医药指数上涨1.06%。本周上涨个股数量335家，下跌个股数量150家，涨幅居前为热景生物（+38.63%）、贝瑞基因（+34.39%）、安必平（+25.72%）、艾迪药业（+19.90%）和圣湘生物（+18.17%），跌幅居前为江苏吴中（-14.34%）、ST三圣（-9.83%）、百利天恒-U（-9.44%）、四环生物（-9.24%）和*ST龙津（-8.23%）。

➤ **中国千万人量级痛风领域有望迎来重磅新药，建议关注一品红。**中国痛风患者人数超千万，且随着当前饮食结构变化患病人数或将持续上升，目前主流治疗药物均有一定缺陷（疗效或安全性问题），我们认为中国痛风药物治疗市场尚未打开，未来有望出现重磅级别的治疗痛风新药。目前临床上新药开发主要集中在新型URAT1抑制剂领域，国内方面，2024年12月，卫材药业的多替诺雷在中国获批上市；2025年1月，恒瑞医药的SHR4640中国上市申请获得受理。此外，国内目前处于临床III期或II/III期的在研药物有YL-90148（上海瓊黎药业）、XNW3009（信诺维医药）、HP501（海创药业）、ABP-671（新元素药业）、AR882（一品红）等。一品红公司的AR882目前已经完成国内III期临床首例患者入组和全球III期试验REDUCE 2受试者入组，AR882为新一代URAT1抑制剂，克服上一代URAT1抑制剂雷西纳德和苯溴马隆的缺点，建议重点关注。

➤ **投资观点及建议关注标的：**医药经过连续4年下跌，已呈现多重底信号，板块估值、持仓均处于近年来低位，2025年业绩也有望迎来企稳回升。展望2025年，医药具备多方面的积极发展因素，1）国内创新产业已具规模，一批药企的创新布局迎来收获，传统pharma也已经完成创新的华丽转身；2）出海能力持续提升，创新药械的license out频频出现，中国企业已成为全球MNC非常重视的创新转换来源，另外医疗设备、供应链等已在全球范围内占据较高的地位，在欧美发达市场以及新兴市场持续崭露头角；3）老龄化持续加速，心脑血管、内分泌、骨科等慢性疾病需求持续提升，银发经济长坡厚雪；4）支付端看，医保收支仍在稳健增长，同时医保局积极推动商业保险的发展，构建多层次支付体系；5）AI浪潮下，医药有望释放新的成长逻辑，短期信心有望显著提升。具体配置方面，建议关注创新药械（业绩/创新拐点的Pharma以及临床阶段的高价值资产）、出海（CXO及科研上游、供应链、医疗器械及高端生物药和制剂）、国产替代（医疗设备和高值耗材）、老龄化及院外消费（家用器械、中药等）、高壁垒行业（血制品、麻药）、AI医疗，同时建议积极关注估值较低有望修复的优质标的。

➤ **本周建议关注组合：**一品红、热景生物、昆药集团、麦澜德、三生制药；

➤ **三月建议关注组合：**昆药集团、人福医药、海泰新光、美好医疗、鱼跃医疗、科兴制药、恒瑞医药、信立泰、三生制药、热景生物。

风险提示：行业竞争加剧风险，政策变化风险，行业需求不及预期风险。

内容目录

1. 痛风人群超千万，新型 URAT1 抑制剂市场前景广阔	4
2. 行业观点：坚持创新+出海+老龄化主线，关注估值修复机会	11
3. 风险提示	17

图表目录

图表 1: 治疗高尿酸/痛风的药物一览	4
图表 2: URAT1 抑制剂作用机制简单示意图	5
图表 3: 国内已经进入临床二期阶段的 URAT1 抑制剂一览	5
图表 4: 部分代表性 URAT1 抑制剂分子结构式一览	6
图表 5: URAT1 结合不同分子的电镜密度图	6
图表 6: URAT1 底物转运与药物抑制机制卡通模型图	6
图表 7: 多替诺雷中国三期临床降尿酸情况	7
图表 8: SHR4640 二期临床试验降尿酸情况	8
图表 9: 平均尿酸降低水平和达标率	9
图表 10: 患者治疗后目标痛风石 (≥ 1 个) 完全溶解的反应率	9
图表 11: 本周申万医药行业涨幅 Top10	11
图表 12: 本周申万医药行业跌幅 Top10	11
图表 13: 2024 年初至今医药指数表现	12
图表 14: 申万各板块年初至今涨跌幅情况	12
图表 15: 年初至今医药子板块涨跌幅情况	13
图表 16: 本周医药子板块表现情况	13
图表 17: 申万各板块 PE 估值情况 (截至 2025 年 3 月 7 日, 整体 TTM 法)	13
图表 18: 申万医药及沪深 300 PE 估值情况 (截至 2025 年 3 月 7 日, 整体 TTM 法)	14
图表 19: 申万医药各细分板块 PE 估值情况 (截至 2025 年 3 月 7 日, 整体 TTM 法)	14
图表 20: 2024 年初至今医药成交额及占 A 股比例 (万亿)	15

1. 痛风人群超千万，新型 URAT1 抑制剂市场前景广阔

正常情况下人体肾脏能够排出尿酸而维持尿酸在血液中的正常浓度水平，而高尿酸血症则常由嘌呤代谢紊乱和/或尿酸排泄减少所导致。痛风则是指因尿酸过高而沉积在关节、组织中造成多种损害的一组疾病，异质性较强，严重者可并发心脑血管疾病、肾功能衰竭，最终可能危及生命。

根据《痛风及高尿酸血症基层诊疗指南（2019 年）》数据，近几年中国高尿酸血症和痛风患病率显著增高，高尿酸血症患者已占总人口 13.3%，而痛风患病率在 1%~3%，我们估算中国痛风患者人数超千万。同时该指南流行病学指出，痛风/高尿酸血症与多种慢性病的发生发展密切相关，如代谢性疾病，心、脑血管病和肾脏疾病等。

目前国内已经上市治疗高尿酸/痛风的药物主要有三类：1）抑制尿酸生成的黄嘌呤氧化酶抑制剂（如别嘌醇和非布司他）；2）促尿酸排泄的 URAT1 抑制剂（如丙磺舒、苯溴马隆和雷西纳德）；3）尿酸氧化酶类似物等。但以上药物都有较为明显的临床缺陷，如丙磺舒活性弱，半衰期短，会降低肾小球滤过率，而且与常用药物之间存在显著药物相互作用。苯溴马隆活性较强，但由于肝毒性等原因，已经在欧洲撤市；雷西纳德（2015 年美国上市）同样由于肾脏毒性被黑框警告。

图表 1：治疗高尿酸/痛风的药物一览

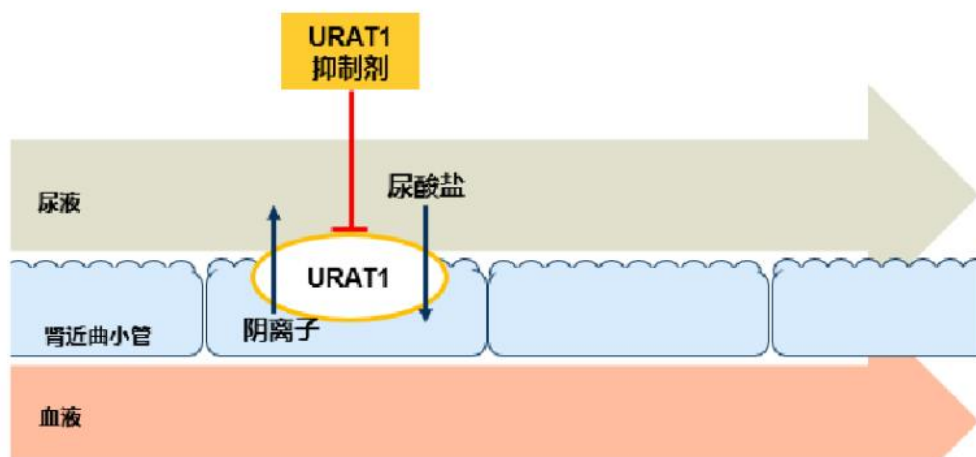
类型	代表药物	不良反应
抑制尿酸生成的黄嘌呤氧化酶抑制剂	包括别嘌醇和非布司他	(1)别嘌醇可能会引起严重的超敏反应综合征。 (2)非布司他因为心血管安全性的争议,已经受到了 FDA 的黑框警告。
促尿酸排泄的 URAT1 抑制剂	包括丙磺舒、苯溴马隆和雷西纳德	(1)丙磺舒的降尿酸效果较差，并且可能与许多常用药物发生相互作用。 (2)苯溴马隆由于其潜在的严重肝损害风险，FDA 未批准其上市。 (3)雷西纳德则因频繁的肾脏不良反应，在国内尚未获批，并且 FDA 也对其发出了可能引发急性肾衰竭的黑框警示。
分解尿酸的尿酸氧化酶类似物	尿酸氧化酶	FDA 对这些药物发出了多条黑框警告,指出它们在 20%-40%的患者中可能会引起严重的免疫过敏性副反应。
急性痛风消炎止疼药物	皮质激素、秋水仙碱	(1)皮质激素对机体免疫系统产生抑制作用，会降低机体防御系统。 (2)秋水仙碱常伴有腹泻、呕吐、腹痛性痉挛等常见的不良反应，且细胞毒性大，一旦药物过量几乎没有解救措施。

资料来源：医药魔方微信公众号，华源证券研究所

高尿酸血症通常是由于尿酸产生过多和/或尿酸排泄减少引起，根据《尿酸盐转运体 1 抑制剂的设计、合成及活性研究》王永成等，尿酸排泄减少在高尿酸血症患者病因中约占 90%，通过增加尿酸排泄的途径来降尿酸是医学上较为理想的治疗方法。

尿酸盐转运体 1 (URAT1)是调控尿酸重吸收的重要蛋白，URAT1 位于近曲小管的管腔膜上，负责将尿酸盐从小管液（尿液）中重吸收到近曲小管细胞，URAT1 抑制剂可以通过抑制尿酸盐的重吸收，从而促进尿酸从体内的排泄并降低血尿酸水平，且相较其他转运蛋白对尿酸具有更高的亲和力和运转效率。

图表 2：URAT1 抑制剂作用机制简单示意图



资料来源：药闻窗微信公众号，华源证券研究所

由于 URAT1 抑制剂是较为理想的痛风治疗药物，目前有多家公司正在开发新型 URAT1 抑制剂。国内方面，2024 年 12 月，卫材药业的新型 URAT1 抑制剂多替诺雷（商品名：优乐思）在中国获批上市；2025 年 1 月，恒瑞医药的新型 URAT1 抑制剂 SHR4640 中国上市申请获得受理。此外，国内目前处于临床 III 期或 II/III 期的在研药物有 YL-90148（上海瓊黎药业）、XNW3009（信诺维医药）、HP501（海创药业）、ABP-671（新元素药业）、AR882（一品红）等。

图表 3：国内已经进入临床二期阶段的 URAT1 抑制剂一览

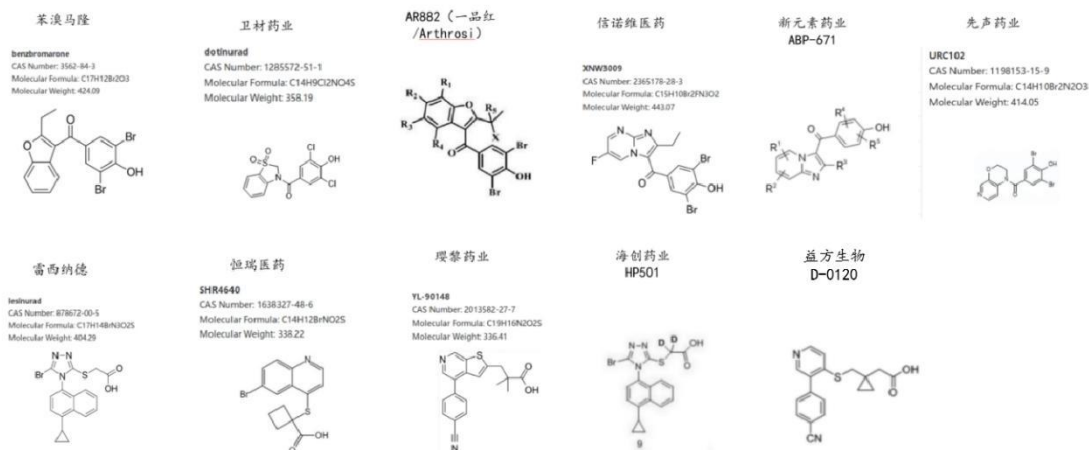
登记号	试验分期	试验状态	靶点	适应症	主试验药	剂型	申办方	首次公示日期
CTR20222473	Phase III	进行中(招募中)	URAT1; XO	高尿酸血症	YL-90148	片剂	上海瓊黎药业	2022-12-14
CTR20222360	Phase IIb/III	进行中(招募中)	URAT1; XO	高尿酸血症	XNW3009	片剂	信诺维医药	2022-10-27
CTR20240587	Phase II/III	已完成	URAT1	高尿酸血症	HP501	缓释片	海创药业	2024-03-01
CTR20233710	Phase IIb/III	进行中(招募中)	URAT1	高尿酸血症	ABP-671	片剂	新元素药业	2023-12-14
CTR20241026	Phase II/III	进行中(招募中)	URAT1	高尿酸血症	AR882	胶囊剂	一品红	2024-04-02
CTR20240980	Phase II	已完成	URAT1; XO	高尿酸血症	THDBH151	片剂	东宝紫星(杭州)生物	2024-03-26
CTR20232057	Phase II	已完成	URAT1	高尿酸血症	WXSH0493	片剂	康缘药业	2023-07-10
CTR20223008	Phase IIa	已完成	URAT1	高尿酸血症	泰宁纳德	片剂	天津药物研究院	2022-11-17
CTR20222979	Phase IIa	已完成	URAT1; XO	高尿酸血症	THDBH130	片剂	通化东宝	2022-11-17
CTR20221594	Phase IIb	已完成	URAT1; XO	高尿酸血症	D-0120-NA	片剂	益方生物	2022-06-28

资料来源：医药魔方，华源证券研究所

目前在研新型 URAT1 抑制剂化合物骨架结构大多是基于上一代雷西纳德或苯溴马隆骨架进行设计，以期解决它们在肾脏、肝脏、或有效性上的问题。基于苯溴马隆改造的药物包括多替诺雷（卫材药业）、AR882（一品红）、XNW3009（信诺维医药）、ABP-671（新

元素药业)、URC102(先声药业);基于雷西纳德改造的药物包括 SHR4640(恒瑞医药)、YL-90148(上海瓊黎药业)、HP501(海创药业)和 D-0120(益方生物)。

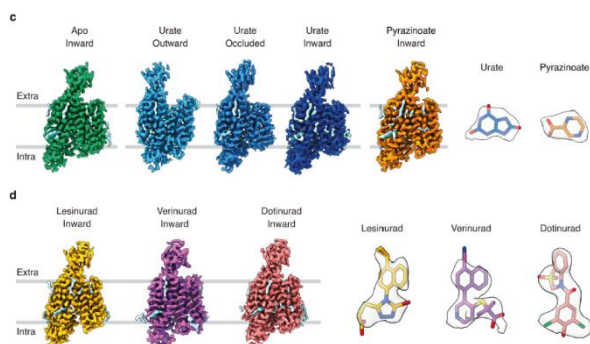
图表 4: 部分代表性 URAT1 抑制剂分子结构式一览



资料来源: 医药魔方, 华源证券研究所

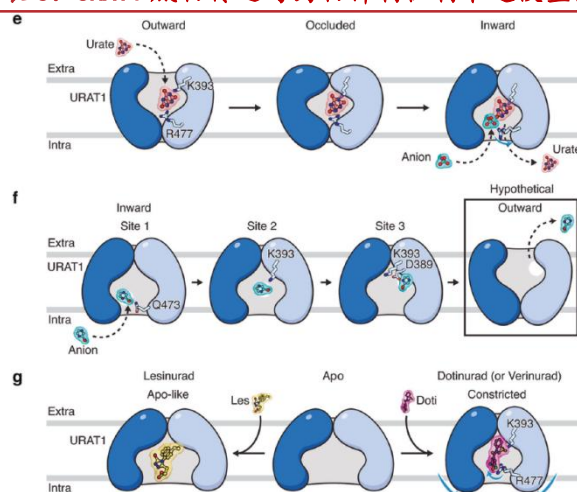
不同的 URAT1 抑制剂分子结构, 对药理特性会产生一定影响, 根据 2024 年发表在《Cell Research》杂志上的研究成果显示, 研究团队选择 lesinurad(雷西纳德)、verinurad 和 dotinurad(多替诺雷)三款药物与 URAT1 进行相互结合的冷冻电镜研究, 发现其与 URAT1 结构空间位点以及结合强度上会有所不同, 可能是其最终药理药效产生不同的主要原因之一。

图表 5: URAT1 结合不同分子的电镜密度图



资料来源: Cell Research, 华源证券研究所

图表 6: URAT1 底物转运与药物抑制机制卡通模型图



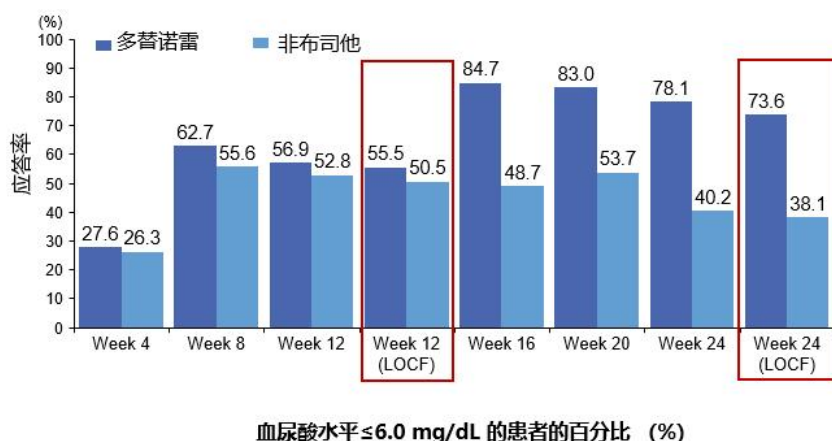
资料来源: Cell Research, 华源证券研究所

从临床数据结果来看：

1) 多替诺雷（卫材药业）

2024 年 12 月在中国获批上市，在中国 III 期研究中，**4mg 多替诺雷治疗 24 周血尿酸小于等于 6mg/d (360 μ mol/L) 的患者比例为 73.6%**，显著高于 40mg 非布司他组的 38.1%。在日本开展的 III 期研究中，使用 58 周多替诺雷对肝肾功能无明显影响且多替诺雷 4mg 尿酸达标率 100.00%，在轻中度肾功能不全患者中无需调整剂量，并且多项临床研究均未发现严重心血管不良反应。

图表 7：多替诺雷中国三期临床降尿酸情况



血尿酸水平 ≤ 6.0 mg/dL 的患者的百分比 (%)

资料来源：国标医药微信公众号，华源证券研究所

2) SHR4640（恒瑞医药）

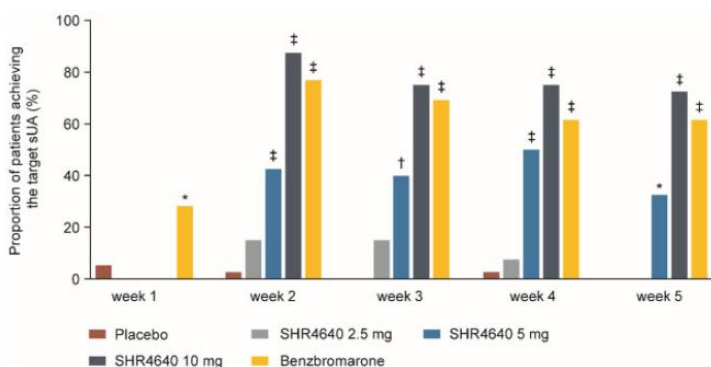
2025 年 1 月中国上市获受理，在其双盲对照 II 期试验 FOCUS 中，评估 SHR4640 单药在患有或不患有痛风的高尿酸血症（HUA）受试者的疗效和安全性，主要终点是第 5 周 sUA $\leq 360 \mu$ mol/L 受试者比例。

II 期临床数据显示：**第 5 周时达到 sUA $\leq 360 \mu$ mol/L 的受试者比例在 5mg SHR4640 组中为 32.5%，在 10mg SHR4640 组中为 72.5%，在苯溴马隆组中为 61.5%**。与安慰剂组相比，5mg 和 10mg SHR4640 组中第 5 周达到 sUA $\leq 360 \mu$ mol/L 的受试者显著增多；与苯溴马隆组相比，10mg SHR4640 组达到目标 sUA 水平的受试者比例较高（72.5%vs 61.5%）。

2024 年 8 月，SHR4640 治疗原发性痛风伴高尿酸血症受试者的 III 期临床试验终点达到方案预设的优效标准，研究共入组 779 例原发性痛风伴高尿酸血症受试者，分别接受 SHR4640 或别嘌醇治疗。研究结果表明，SHR4640 达到了主要研究终点及次要研究终点，与别嘌醇相比，SHR4640 对原发性痛风伴高尿酸血症有统计学显著性和临床意义更优效的改善。同时，SHR4640 在原发性痛风伴高尿酸血症患者中的安全性、耐受性良好。

图表 8：SHR4640 二期临床试验降尿酸情况

Fig. 2 Proportion of subjects that achieved a sUA $\leq 360 \mu\text{mol/l}$ at each weekly visit



* $P < 0.05$ vs placebo; † $P < 0.01$ vs placebo; ‡ $P < 0.001$ vs placebo. sUA: serum uric acid.

资料来源: Efficacy and safety of a selective URAT1 inhibitor SHR4640 in Chinese subjects with hyperuricaemia: a randomized controlled phase II study, 华源证券研究所

3) AR882 (一品红)

2025 年 3 月, AR882 完成国内 III 期临床首例患者入组; 同月, AR882 完成全球 III 期试验 REDUCE 2 受试者入组。

AR882 克服了雷西纳德和苯溴马隆的缺点, 能够与尿酸转运蛋白长效结合, 延长抑制作用的时间, 临床结果显示其药效长达 24 小时, 且全天候的阻断尿酸重吸收不会加重肾负荷, 可以避免肾毒性, 并有效清除体内尿酸, 达到溶解痛风石的目的。在一项随机开放的全球 II 期研究中 (美国, 新西兰及中国台湾), 试验招募了 42 名至少有 1 个皮下痛风石患者, 患者被随机分为三组, 以 1:1:1 的比例分别接受每日一次 AR882 (75mg)、AR882 (50mg) + 别嘌醇、别嘌醇 (至多 300mg) 的治疗。

降尿酸方面: 第 3 个月时, AR882 75mg 组、AR882 50 mg+别嘌醇组和别嘌醇组的平均 sUA 水平分别降至 $4.5 (\pm 1.2)$ 、 $4.7 (\pm 1.4)$ 和 $6.1 (\pm 2.0)$ mg/dL。在 75 mg AR882 组中, 分别有 86% 和 64% 的患者达到了 sUA < 6 mg/dL 和 < 5 mg/dL 的水平; 在 50mg AR882+ 别嘌醇组中, 分别有 77% 和 69% 的患者达到了 sUA < 6 mg/dL 和 < 5 mg/dL 的水平。相比之下, 别嘌醇组达到 sUA < 6 mg/dL 和 < 5 mg/dL 的水平的患者比例为 46% 和 23%。

溶解痛风石方面: 第 3 个月, AR882 75mg 组、AR882 50mg+别嘌醇组和别嘌醇组中位 sUA 水平分别降至 4.5 mg/dL、4.7 mg/dL 和 6.1 mg/dL。第 12 个月, AR882 75mg、AR882 50mg+别嘌醇和 AR882 75mg+别嘌醇组的 sUA 水平分别为 4.3 mg/dL、3.7 mg/dL 和 2.9 mg/dL。第 6 个月, 在 AR882 75mg 组中, 有 4 例患者 (29%) 测量到了痛风石的完全消除, 别嘌醇组 1 例 (8%), AR882 50mg+别嘌醇组 1 例 (8%)。在第 6-12 个月的延长期试验中, AR882 75mg 组和 AR882 75mg+别嘌醇组分别有 4 例 (40.0%) 和 4 例 (36.4%) 患者的痛风结石完全溶解。AR882 75mg 单独使用或与别嘌醇联合使用显示, 从基线到第 6 个月, 总尿酸晶体体积减少; 第 6 至 12 个月的拓展研究中, 痛风晶体体积持续减少。

在整个 12 个月的慢性治疗中，AR882 作为单一疗法或与别嘌醇联合治疗组试验患者耐受性良好。最常见的不良事件是痛风发作，轻度或中度不良事件包括腹泻、头痛和上呼吸道感染。AR882 治疗后，试验患者痛风结石率持续下降。

图表 9：平均尿酸降低水平和达标率

表 1. 平均 sUA 降低水平和达标率

治疗组	基线	第三个月时的血尿酸水平		第 3 个月时的血尿酸 (mg/dL) 达标率, %			
	血尿酸 mg/dL	血尿酸 mg/dL	变化率%	<6	<5	<4	<3
AR882 75 mg	9.1	4.5	-49.6	86	64	43	7
AR882 50 mg+别嘌醇	9.6	4.7	-49.9	77	69	23	8
别嘌醇	9.5	6.1	-34.9	46	23	15	8

资料来源：一品红公司微信公众号，华源证券研究所

图表 10：患者治疗后目标痛风石 (≥ 1 个) 完全溶解的反应率

统计期间	AR882 75mg (N=14)	AR882 50mg+ 别嘌醇 (N=13)	别嘌醇 (N=13)	AR882 75mg+ 别嘌醇 (N=11)
基线到第 6 个月	4/14 (28.6%)	1/13 (7.7%)	1/13 (7.7%)	-
第 6-12 个月	4/10 (40.0%)	1/8 (12.5%)	-	4/11 (36.4%)
基线到第 12 个月	*5/14 (35.7%)	1/13 (7.7%)	-	-

资料来源：一品红公司微信公众号，华源证券研究所

4) XNW3009 (信诺维医药)

2024 年 2 月，信诺维医药的 XNW3009 完成 III 期临床试验首例患者入组。2022 年 1 月，信诺维医药披露 XNW3009 的 II 期临床数据，0.5mg 剂量组每次给药即可实现超过 72% 的受试者血清尿酸浓度 $\leq 360\mu\text{mol/L}$ ，对照组苯溴马隆 50mg 剂量组的有 51.9% 的受试者血清尿酸浓度 $\leq 360\mu\text{mol/L}$ 。与苯溴马隆相比 XNW3009 片剂量组展现了优异的降尿酸疗效。且安全耐受性良好，不良事件多为 1~2 级的轻度不良事件，未见明显的肝、肾毒副作用，同时在临床药理学方面也展现了良好的药代和药效动力学特征。痛风患者常常伴随高血压、高血糖、高血脂等疾病，XNW3009 无 CYP 酶诱导作用，产生 PK 相关的药物间相互作用可能性较小，临床使用便利。2024 年 2 月，XNW3009 完成 III 期临床试验的首例患者入组。

5) ABP-671 (新元素药业)

2023 年 10 月，新元素药业的 ABP-671 完成 IIb/III 期临床试验首例患者入组。2022 年 3 月，新元素药业披露 ABP-671 的 2a 期临床试验数据，60 例患者随机接受每日 2 mg、4 mg 或 8 mg 剂量水平的 ABP-671 或安慰剂治疗。入组时，试验中所有患者的平均 sUA 水平均大于 8 mg/dL。试验结果显示，ABP-671 具有良好的药效、安全性和耐受性。所有三个 APB-671 剂量组的平均 sUA 水平都达到低于 6 mg/dL 的主要终点。并且，ABP-671 剂量越高，患者 sUA 水平成比例降低更多。

6) D-0120 (益方生物)

D-0120 的 IIa 期临床试验是一项随机、双盲、安慰剂对照、多次给药、多剂量爬坡的研究，主要目的是评估 D-0120 多次给药剂量递增在高尿酸血症患者（痛风或无症状）中的安全性和耐受性；次要目标是评估 D-0120 多次给药剂量递增在高尿酸血症患者（痛风或无症状）中的药代动力学（PK）和药效动力学（PD）特征。

根据 IIa 期临床试验的初步分析结果，D-0120 在高尿酸血症患者中安全性耐受性良好，大多数与研究药物相关的不良事件为 1、2 级，没有因不良反应导致的停药或死亡。D-0120 在目标剂量下患者的血尿酸达标率 80%，显示出了优良的降尿酸效果。

7）HP501（海创药业）

临床 II 期试验初步结果表明，血尿酸降低达标率存在剂量依赖性；40 mg/天剂量组和 50 mg/天剂量组血尿酸降低达标率分别为 32%和 43%，均高于上市药物雷西纳德 III 期临床数据（200 mg/天和 400 mg/天血尿酸降低达标率分别为 28%和 30%）；安全性良好，未发现与药物相关的严重不良反应，不良事件发生率无剂量依赖性、与安慰剂组无显著差异。安慰剂组和治疗组中各有 1 例次转氨酶轻度升高（小于正常上限的 1.5 倍），试验组中（低剂量）有 1 例轻度血肌酐升高（小于正常上限的 1.5 倍）。II 期试验初步结果表明，HP501 安全有效，尚未发现肝肾毒副作用。

2. 行业观点：坚持创新+出海+老龄化主线，关注估值修复机会

本周（3.3-3.7）、年初至今医药指数涨跌幅分别为 1.06%和 2.19%，相对沪深 300 指数的超额收益分别为-0.32%和 1.95%。

个股情况：本周上涨个股数量 335 家，下跌个股数量 150 家，涨幅居前为热景生物（+38.63%）、贝瑞基因（+34.39%）、安必平（+25.72%）、艾迪药业（+19.90%）和圣湘生物（+18.17%），跌幅居前为江苏吴中（-14.34%）、ST 三圣（-9.83%）、百利天恒-U（-9.44%）、四环生物（-9.24%）和*ST 龙津（-8.23%）。

图表 11：本周申万医药行业涨幅 Top10

排序	代码	名称	市值（亿元）	本周表现	本月至今表现	年初至今表现
1	688068.SH	热景生物	86.3	38.63%	38.63%	50.87%
2	000710.SZ	贝瑞基因	61.2	34.39%	34.39%	104.85%
3	688393.SH	安必平	37.6	25.72%	25.72%	132.41%
4	688488.SH	艾迪药业	41.6	19.90%	19.90%	25.70%
5	688289.SH	圣湘生物	146.2	18.17%	18.17%	11.15%
6	688302.SH	海创药业-U	38.4	16.58%	16.58%	26.38%
7	002755.SZ	奥赛康	154.4	15.89%	15.89%	30.84%
8	000504.SZ	南华生物	35.9	15.48%	15.48%	30.42%
9	688319.SH	欧林生物	63.2	14.47%	14.47%	46.98%
10	300683.SZ	海特生物	32.5	14.16%	14.16%	4.77%
11	801150.SI	医药生物(申万)		1.06%	1.06%	2.19%
12	000300.SH	沪深 300		1.39%	1.39%	0.23%

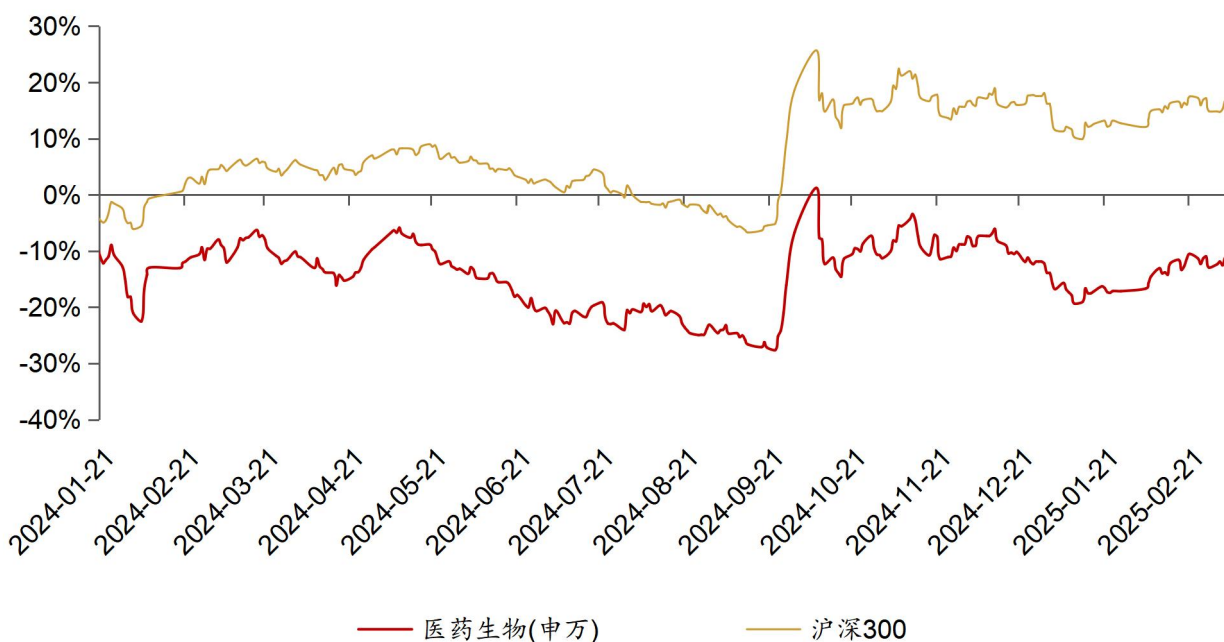
资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 12：本周申万医药行业跌幅 Top10

排序	代码	名称	市值（亿元）	本周表现	本月至今表现	年初至今表现
1	600200.SH	江苏吴中	44.2	-14.34%	-14.34%	-33.37%
2	002742.SZ	ST 三圣	16.2	-9.83%	-9.83%	-8.52%
3	688506.SH	百利天恒-U	846.1	-9.44%	-9.44%	10.05%
4	000518.SZ	四环生物	22.2	-9.24%	-9.24%	-14.62%
5	002750.SZ	*ST 龙津	5.8	-8.23%	-8.23%	-33.79%
6	688062.SH	迈威生物-U	72.5	-7.96%	-7.96%	-10.15%
7	688293.SH	奥浦迈	45.2	-7.48%	-7.48%	9.24%
8	301097.SZ	天益医疗	23.1	-6.79%	-6.79%	6.94%
9	300147.SZ	香雪制药	62.4	-5.79%	-5.79%	-3.48%
10	688426.SH	康为世纪	25.8	-5.02%	-5.02%	-19.96%
11	801150.SI	医药生物(申万)		1.06%	1.06%	2.19%
12	000300.SH	沪深 300		1.39%	1.39%	0.23%

资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 13：2024 年初至今医药指数表现



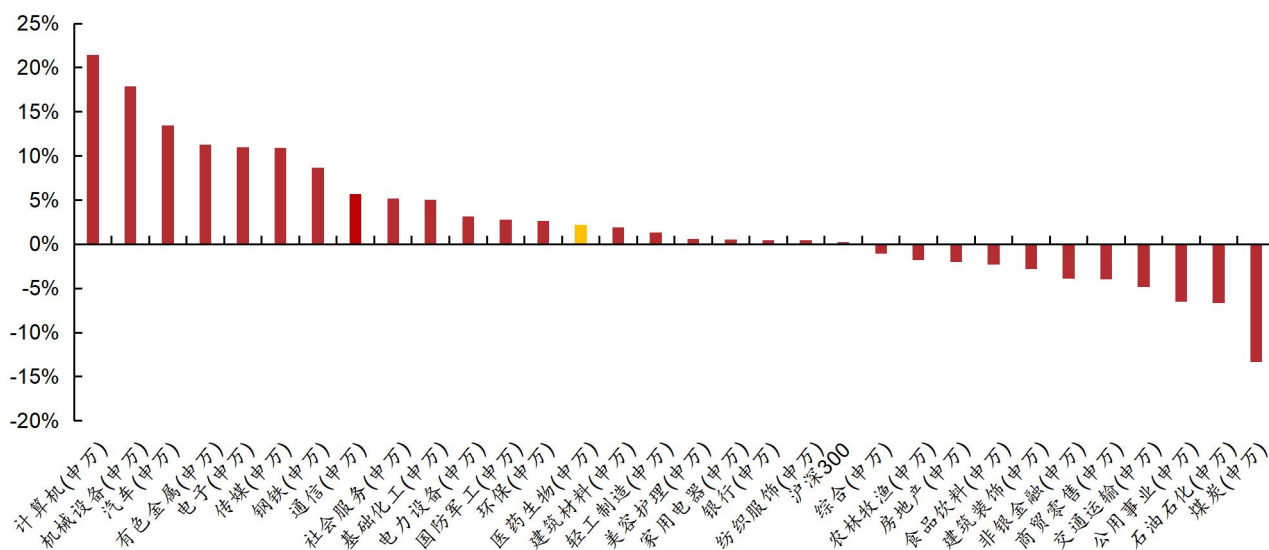
资料来源：Wind, 华源证券研究所

细分赛道涨跌幅情况：

本周，医疗服务（+2.6%）、化学原料药（+2.1%）、医疗器械（+1.3%）表现相对较好，中药（+0.2%）、化学制剂（+0.5%）、医药商业（+0.6%）相对涨跌幅靠后。

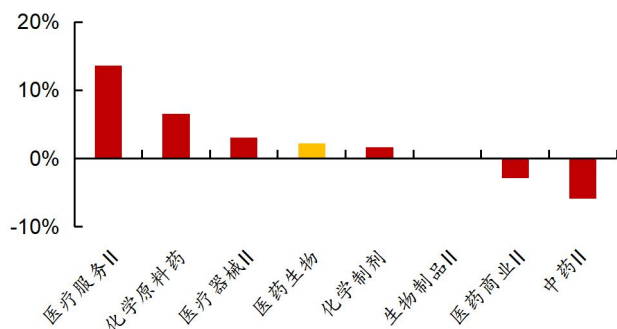
年初以来，医疗服务（+13.6%）、化学原料药（+6.6%）、医疗器械（+3.0%）涨跌幅排名靠前，中药（-5.9%）、医药商业（-2.9%）、生物制品（0%）相对涨跌幅靠后。

图表 14：申万各板块年初至今涨跌幅情况



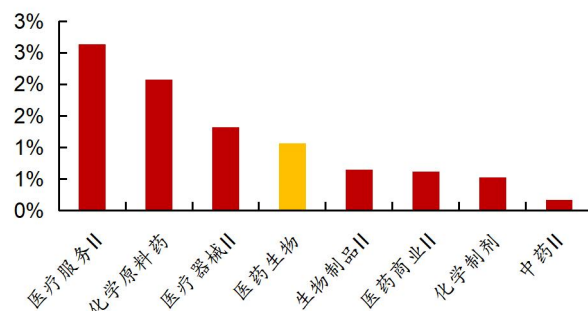
资料来源：Wind, 华源证券研究所

图表 15: 年初至今医药子板块涨跌幅情况



资料来源: Wind, 华源证券研究所

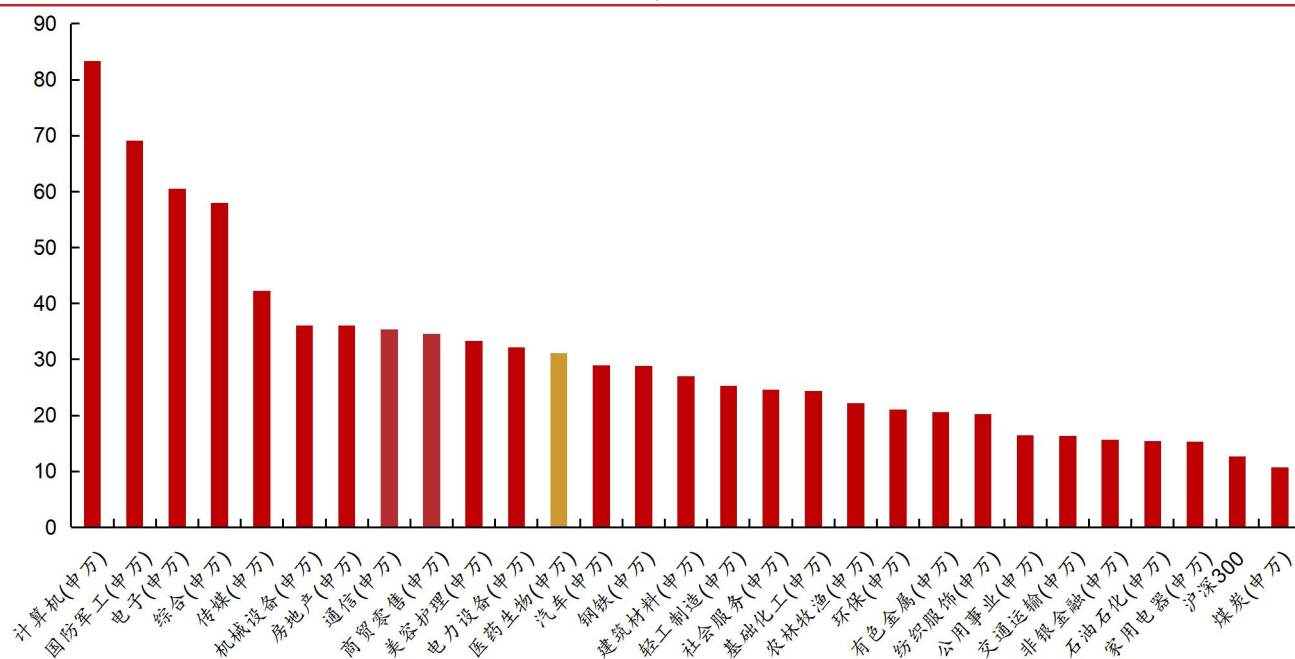
图表 16: 本周医药子板块表现情况



资料来源: Wind, 华源证券研究所

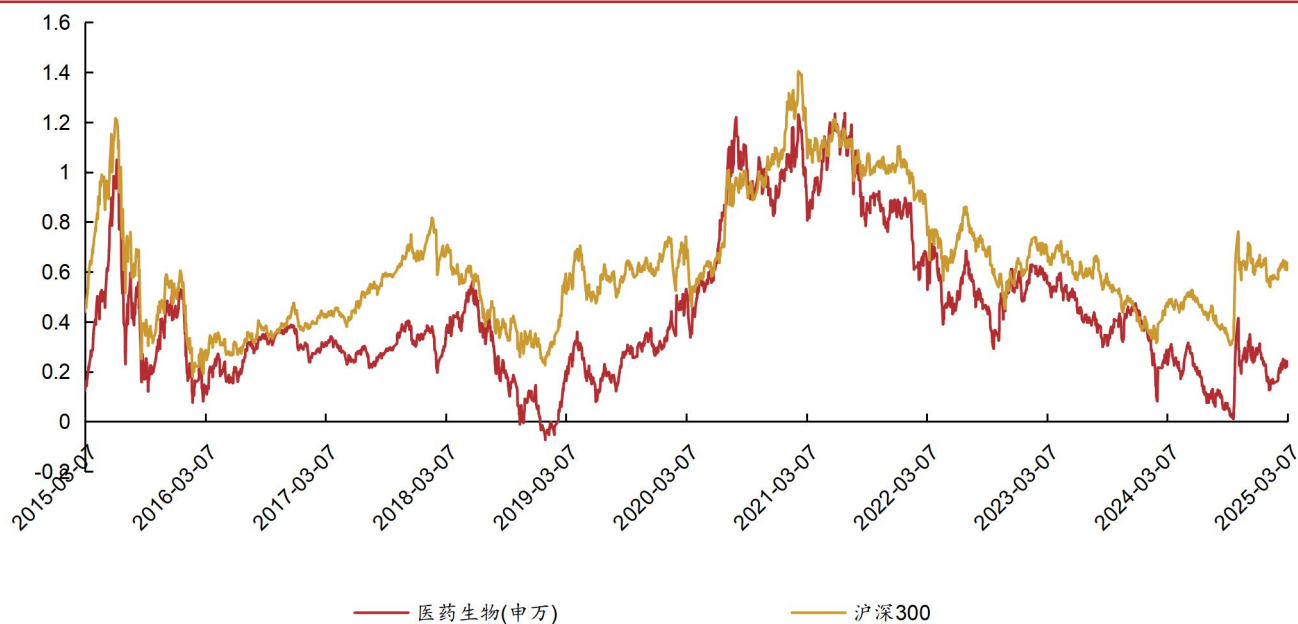
板块估值: 截至 2025 年 3 月 7 日, 申万医药板块整体 PE 估值为 31.19X, 在申万一级分类中排第 12, 从 PE 绝对值来看, 目前医药估值仍在历史相对较低位置。各细分板块估值情况, 目前医疗服务、化学制剂和化学原料药等板块估值相对较高, 医药商业和中药估值相对较低。

图表 17: 申万各板块 PE 估值情况 (截至 2025 年 3 月 7 日, 整体 TTM 法)



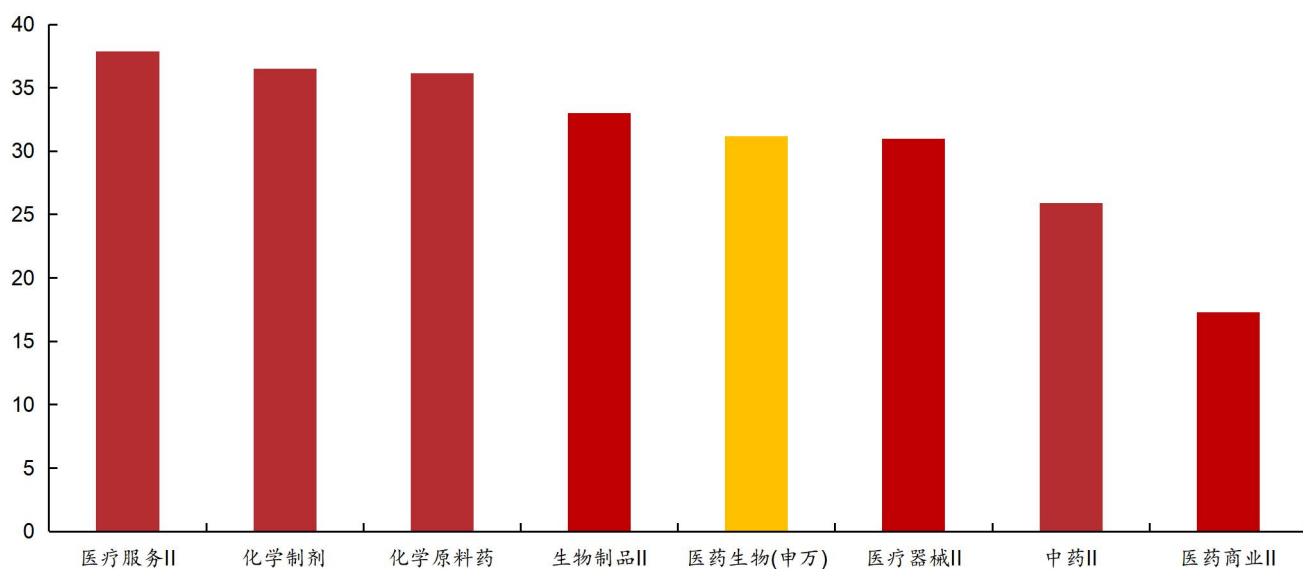
资料来源: Wind, 华源证券研究所

图表 18: 申万医药及沪深 300 PE 估值情况 (截至 2025 年 3 月 7 日, 整体 TTM 法)



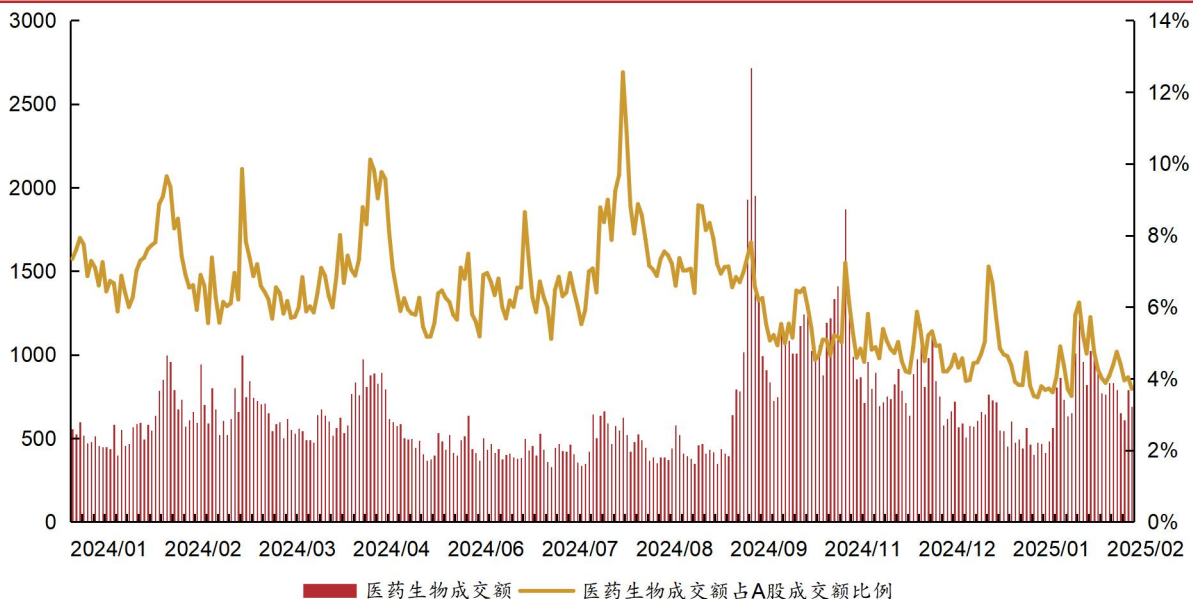
资料来源: Wind, 华源证券研究所

图表 19: 申万医药各细分板块 PE 估值情况 (截至 2025 年 3 月 7 日, 整体 TTM 法)



资料来源: Wind, 华源证券研究所

图表 20：2024 年初至今医药成交额及占 A 股比例（万亿）



资料来源：Wind，华源证券研究所

投资观点：2024 年医药指数下跌超 14%，我们认为核心原因是新一轮医改进入深水区、政策扰动加速、企业成长动能转换带来阵痛所致，其中行业整顿持续进行，院内 DRG/DIP 进一步推广，院外医保品种政策调整，以及集采持续扩面等。当前位置，我们认为医药已经呈现多重底，医改影响或逐步调整到位，板块估值、持仓均处于近年来低位，业绩也有望迎来企稳回升。具体来看，目前医药板块整体 PE 估值为 31.19X 左右，处于历史较低位置。展望 2025 年，我们认为医药具备多方面的积极发展因素，1）创新产业已经初具规模，多家公司的创新布局迎来收获，传统 pharma 也已经完成创新的华丽转身；2）出海能力持续提升，创新药械的 license out 频频出现，中国企业已成为全球 MNC 非常重视的创新转换来源；3）老龄化持续加速，银发经济长坡厚雪；4）支付端看，医保收支仍在稳健增长，同时医保局积极推动商业保险的发展，构建多层次支付体系；5）AI 浪潮下，医药有望迎来新发展机遇，释放新的增长潜力。

整体来看，我们认为当前医改影响或逐步调整到位，行业有望边际好转，看好 2025 年医药否极泰来，结构性高增长的细分领域和个股值得期待。25Q1 医药申万行业反弹概率较大，当前位置适合战略性布局，坚持“创新+出海+老龄化”主线，重点布局低估资产，建议关注以下方向：

1) 创新药械及产业链：国务院明确表态支持创新药全产业链发展，多地陆续出台相关政策，我们认为创新药/械及产业是较为明确的产业趋势，建议关注恒瑞医药、科伦药业、信立泰、科伦博泰、康方生物、和黄医药、翰森制药、中国生物制药、三生制药、信达生物、泽璟制药、热景生物、科兴制药、广生堂、赛诺医疗等。产业链方面，建议关注药明康德、药明生物、药明合联、凯莱英、泰格医药、百普赛斯、毕得医药等。

2) 出海: 欧美占据全球医药主要市场份额, 市场空间大, 新兴市场正在快速发展, 海外潜在增量十分可观, 建议关注迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、鱼跃医疗、三诺生物、美好医疗、海泰新光、科兴制药等。

3) 国产替代: 国产替代依旧是未来几年较为确定的产业趋势, 其中内窥镜、微电生理等市场空间大、竞争格局好、国产率低, 主要建议关注开立医疗、澳华内镜、惠泰医疗、微电生理等。

4) 老龄化及院外消费: 随着 50 岁以上的老年化群体持续扩大, 相关的健康消费需求有望稳步增长, 建议关注昆药集团、鱼跃医疗、可孚医疗、华润三九、同仁堂、马应龙、羚锐制药、盘龙药业等。

5) 高壁垒行业: 麻药和血制品行业需求较为稳健, 供给端相对稳定, 建议关注麻药 (人福医药、恩华药业、国药股份等)、血制品 (派林生物、天坛生物、博雅生物等)。

6) 小而美标的: 随着市场情绪显著好转, 部分前期估值受到压制、但业绩稳健或高增长公司有望迎来估值修复, 建议关注百洋医药、普门科技、盘龙药业、方盛制药、立方制药、麦澜德等。

7) AI 主线或有望贯穿 2025 年, 医药相关板块和个股有望反复表现, 建议关注制药 (晶泰控股、泓博医药)、大数据模型 (润达医疗、美年健康、金域医学、医脉通、阿里健康、华大基因)、医疗设备 (鱼跃医疗、三诺生物、联影医疗、开立医疗、华大智造) 等。

本周建议关注组合: 一品红、热景生物、昆药集团、麦澜德、三生制药;

三月建议关注组合: 昆药集团、人福医药、海泰新光、美好医疗、鱼跃医疗、科兴制药、恒瑞医药、信立泰、三生制药、热景生物。

3. 风险提示

1) 行业竞争加剧风险：随着我国医药产业的不断创新与进步，不排除持续有新进竞争者加入从而造成竞争加剧的风险；

2) 政策变化风险：分级诊疗、医保支付改革持续成为医改重心，医保控费大趋势、带量采购等让医药产业中下游的收入利润有承压风险；

3) 行业需求不及预期风险：若终端需求不及预期，将会对公司业绩产生负面影响。

证券分析师声明

本报告署名分析师在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本报告表述的所有观点均准确反映了本人对标的证券和发行人的个人看法。本人以勤勉的职业态度，专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观的出具此报告，本人所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将会与本报告中的具体投资意见或观点有直接或间接联系。

一般声明

华源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告是机密文件，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司客户。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测等只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特殊需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的意见、评估及推测仅反映本公司于发布本报告当日的观点和判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及推测不一致的报告。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。本公司不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式修改、复制或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华源证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司销售人员、交易人员以及其他专业人员可能会依据不同的假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点，本公司没有就此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

信息披露声明

在法律许可的情况下，本公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司将会在知晓范围内依法合规的履行信息披露义务。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级说明

证券的投资评级：以报告日后的6个月内，证券相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入：相对同期市场基准指数涨跌幅在20%以上；

增持：相对同期市场基准指数涨跌幅在5%~20%之间；

中性：相对同期市场基准指数涨跌幅在-5%~+5%之间；

减持：相对同期市场基准指数涨跌幅低于-5%及以下。

无：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

行业的投资评级：以报告日后的6个月内，行业股票指数相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好：行业股票指数超越同期市场基准指数；

中性：行业股票指数与同期市场基准指数基本持平；

看淡：行业股票指数弱于同期市场基准指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；

投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

本报告采用的基准指数：A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生中国企业指数（HSCEI），美国市场基准为标普500指数或者纳斯达克指数。